

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial

Nota Orientativa nº 15/2025 - SES.DAS

Assunto: **Calendário de Consultas de Puericultura e Odontologia de crianças de 0 a 9 anos completos e adolescentes de 10 a 19 anos completos, na Atenção Primária à Saúde (APS)**

Considerando que o Ministério da Saúde (MS), a fim de garantir a qualidade da assistência prestada à criança na APS propõe um calendário mínimo de consultas de puericultura de rotina;

Considerando que as consultas de puericultura de rotina permitem ao profissional de saúde conhecer a criança nas suas particularidades e assim promover o seu bem-estar biopsicossocial, prevenção precoce de patologias, além de prestar orientações e esclarecimentos referentes às dúvidas pertinentes ao cuidado da criança;

Considerando que a consulta de puericultura de rotina para avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança **pode ser intercalada entre médico e enfermeiro conforme disponibilidade da equipe** e compartilhada com os demais profissionais da Atenção Primária à Saúde (e-multi e odontologia) ou especialidades;

Considerando que o calendário de consultas deve ser flexível, cabendo ao profissional que realizou a última consulta avaliar a data ideal para a próxima consulta da criança;

Considerando que os calendários de consultas devem ser seguidos conforme a classificação de risco da criança (baixo risco, risco intermediário e alto risco), servindo como instrumento para programação da agenda na UBSF, sendo esta classificação passível de mudança conforme avaliação da equipe;

Considerando que a Unidade de Saúde deve ter o controle das crianças da sua área de abrangência por faixa etária para realizar a programação da agenda;

Considerando que a consulta da criança de risco intermediário e alto risco devem ser intercaladas com o pediatra da APS, conforme a avaliação da equipe;

Considerando que a avaliação odontológica da criança é um procedimento essencial para garantir a saúde bucal infantil e faz parte do calendário de

acompanhamento da criança na APS.

A Diretoria de Assistência à Saúde, por meio da Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, elabora e publica Nota Orientativa tratando do **Calendário de Consultas de Puericultura e Odontologia de crianças de 0 a 9 anos completos e adolescentes de 10 a 19 anos completos na Atenção Primária à Saúde (APS)**, conforme quadros abaixo.

1. CRIANÇA DE RISCO HABITUAL/ BAIXO RISCO (CARINHA VERDE)

Crianças com condições sociodemográficas favoráveis, ou seja, risco inerente ao ciclo de vida da criança. Com boa vitalidade e crescimento adequado, condições do nascimento:

- Critérios: APGAR > 7 no 5º minuto;
- Peso ao nascer $\geq 2.500\text{g}$ e $< 4.000\text{g}$;
- Idade gestacional ≥ 37 e < 42 semanas.

As consultas de puericultura devem ser intercaladas entre enfermeiro da ESF e médico da ESF.

Quadro 01. Calendário de consultas e visita/atendimento domiciliar para crianças de risco habitual/baixo risco - Carinha Verde

CRIANÇA DE RISCO HABITUAL/BAIXO RISCO - CARINHA VERDE	
Idade	Profissional
Até 5º dia de vida	Enfermeiro ou Médico
Visita domiciliar (até 30 dias de vida)	Técnico de Enfermagem ou Enfermeiro
30 dias	Médico
2 meses	Enfermeiro ou Médico
4 meses	Médico
6 meses e 9 meses	Enfermeiro ou Médico
12 meses	Médico
15 meses	Enfermeiro ou Médico
18 meses	Médico
24 meses	Enfermeiro ou Médico
A partir dos 2 anos consulta anual no mês de aniversário	Enfermeiro ou Médico

Quadro 02. Calendário de consulta odontológica para crianças de risco habitual/baixo risco - Carinha Verde

CRIANÇA DE RISCO HABITUAL/BAIXO RISCO - CARINHA VERDE (Calendário da Consulta Odontológica)				
Consulta	1º ano	2º ano	3º ano	A partir do 3º ano
Odontológica (individual ou compartilhada)	Até 12 meses	Ao menos 1 (uma) consulta entre 12 e 24 meses	Ao menos 1 (uma) consulta entre 24 e 36 meses	Ao menos 1 (uma) consulta ao ano, próxima à data de aniversário

2. CRIANÇA DE RISCO INTERMEDIÁRIO E ALTO RISCO (CARINHA VERMELHA)

2.1. Crianças de RISCO INTERMEDIÁRIO:

- Crianças cuja genitora foi diagnosticada no pré natal ou parto com toxoplasmose, sífilis, HIV, rubéola, citomegalovírus, herpes vírus ou Zika vírus, sem maiores gravidades;
- Peso ao nascer > 1500g e < 2.500g (sem necessidade de UTI após o nascimento);
- Peso ao nascimento ≥ 4000 g;
- Idade gestacional de nascimento entre ≥ 34 e < 37 semanas ou ≥ 42 semanas;
- Anomalias congênitas menores;
- Atraso no crescimento e desenvolvimento e baixo ganho de peso;
- Vulnerabilidade social;

Quadro 03. Calendário de consultas e visita/atendimento domiciliar para crianças de risco Intermediário - Carinha Vermelha

CRIANÇA DE RISCO INTERMEDIÁRIO - CARINHA VERMELHA	
Idade	Profissional
Até 5º dia após alta	Médico
Visita domiciliar (até 15 dias após alta)	Enfermeiro ou Médico
30 dias	*Pediatra APS
2 meses	Médico
3 meses	Enfermeiro ou Médico
4 meses	Médico
5 meses	Enfermeiro ou Médico



CRIANÇA DE RISCO <u>INTERMEDIÁRIO</u> - CARINHA VERMELHA	
6 meses	Médico
8 meses e 10 meses	Enfermeiro ou Médico
12 meses	Médico
15 meses e 18 meses	Enfermeiro ou Médico
24 meses	Médico
36 meses	Enfermeiro ou Médico
A partir do 3º ano, consulta anual no mês de aniversário	Enfermeiro ou Médico

* Os retornos com Pediatra da APS deverão ser agendadas conforme avaliação deste.

Quadro 04. Calendário de consulta odontológica para crianças de risco intermediário - Carinha Vermelha

CRIANÇA DE RISCO INTERMEDIÁRIO - CARINHA VERMELHA (Calendário da Consulta Odontológica)				
Consulta	1º ano	2º ano	3º ano	A partir do 3º ano
Odontológica (individual ou compartilhada)	Ao menos 1 (uma) consulta nos 12 primeiros meses	Ao menos 1 (uma) consulta entre os 12 e 24 meses	Ao menos 1 (uma) consulta entre os 24 e 36 meses	Ao menos uma consulta ao ano, próximo à data de aniversário.

2.2. Crianças de ALTO RISCO:

São elegíveis para os critérios de acesso ao **Programa Bebê Precioso**, os bebês que **necessitaram de internação em UTI neonatal nos seus primeiros 28 dias de vida**, conforme protocolo de acesso disponível no Processo SEI nº 25.0.088137-1.

Quadro 05. Critérios de Inclusão para o Programa Bebê Precioso

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA O PROGRAMA BEBÊ PRECIOSO	
Recém-Nascido/Bebê que <u>necessitou de UTI Neonatal em seus primeiros 28 dias de vida</u> , com <u>uma ou mais</u> intercorrência/motivos descritas abaixo:	
Asfixia Perinatal	• Apgar menor ou igual a 4 no 5º minuto; • Clínica e/ou alteração laboratorial compatível com Síndrome Hipóxico-Isquêmica; • Parada cardiorrespiratória documentada, com necessidade de reanimação e medicação; • Apnéias repetidas.
Prematuridade	• Idade Gestacional menor ou igual a 33 semanas
Peso de nascimento	• Peso de nascimento menor ou igual a 1.500g.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA O PROGRAMA BEBÊ PRECIOSO

Recém-Nascido/Bebê que **necessitou de UTI Neonatal em seus primeiros 28 dias de vida**, com **uma ou mais** intercorrência/motivos descritas abaixo:

Problemas Neurológicos	• Clínica neurológica (alterações tônicas, irritabilidade, choro persistente); • Convulsão, com uso de drogas anticonvulsivantes; • Hemorragia intracerebral (documentada por ultrassonografia transfontanelar); • Meningite neonatal.
Hiperbilirrubinemia	• Com níveis para exsanguineotransusão;
Policitemia Sintomática/Hiperviscosidade	• Sangramentos; • Trombose, entre outros.
Hipoglicemia Sintomática	• Hipoglicemia que requer tratamento prolongado por mais de 5 dias
Uso de Ventilação Mecânica com sequelas pulmonares	• Pneumotórax; • Pneumomediastino; • Barotrauma.
Infecções Congênitas	• Citomegalovírus; • Herpes; • Rubéola; • Toxoplasmose; • Sífilis.
Malformações Congênitas e Síndromes Genéticas;	• Malformação cardíaca; • Malformação de Membros; • Malformação do tubo neural; • Fendas faciais, entre outras.
Quadro de infecção grave	• Meningite, septicemia com sequelas, entre outros.
Erros Inatos do Metabolismo	• Mucopolissacaridoses; • Fibrose cística; • Glicogenoses; • Aminoacidopatias; • Intolerância aos açúcares

Importante:

- O Bebê em acompanhamento no Programa Bebê Precioso **deverá manter as consultas de puericultura na APS**, intercalando entre enfermeiro, médico da ESF e pediatria.
- Sempre que necessário deve ser realizado o matriciamento e/ou contrarreferência entre o Programa Bebê Precioso e demais Unidades de Saúde da Secretaria da Saúde.



Quadro 06. Calendário de consultas e visita/atendimento domiciliar para crianças de Alto Risco na APS - Carinha Vermelha

CRIANÇA DE ALTO RISCO <u>BEBÊ PRECIOSO</u> - CARINHA VERMELHA	
Idade	Profissional
Até 5º dia após alta	Médico
Visita domiciliar (até 15 dias após alta)	Enfermeiro ou Médico
30 dias	*Pediatra APS
2 meses, 3 meses e 4 meses	Médico
5 meses	Enfermeiro ou Médico
6 meses	Médico
7 meses e 8 meses	Enfermeiro ou Médico
9 meses	Médico
10 meses	Enfermeiro ou Médico
12 meses	Médico
15 meses	Enfermeiro ou Médico
18 meses e 24 meses	Médico
30 meses	Enfermeiro ou Médico
36 meses	Médico
42 meses	Enfermeiro ou Médico
48 meses	Médico
54 meses	Enfermeiro ou Médico
A partir de 5 anos consulta anual no mês de aniversário até 19 anos completos	Enfermeiro ou Médico

* Os retornos com Pediatra da APS deverão ser agendadas conforme avaliação deste.

Quadro 07. Calendário de consulta odontológica para crianças de alto risco - Carinha Vermelha

CRIANÇA DE ALTO RISCO (BEBÊ PRECIOSO) - CARINHA VERMELHA (Calendário da Consulta Odontológica)				
Consulta	1º ano	2º ano	3º ano	A partir do 3º ano
Odontológica (individual ou compartilhada)	Ao menos 1 (uma) consulta nos 12 primeiros meses	Ao menos 1 (uma) consulta entre os 12 e 24 meses	Ao menos 1 (uma) consulta entre os 24 e 36 meses	Ao menos uma consulta ao ano, próximo à data de aniversário.

3. ADOLESCENTES

A sugestão do acompanhamento do desenvolvimento puberal é de realizar consultas com intervalos conforme a fase em que se encontra o adolescente conforme descrito no Quadro 08 abaixo. Os intervalos de retorno serão definidos pelo profissional, conforme a clínica do usuário.

O início da puberdade geralmente **inicia entre 8 e 13 anos nas meninas e dos 9 e 14 anos nos meninos**. Porém cada criança/adolescente deve ser avaliado individualmente, pois as fases variam de pessoa para pessoa.

Quadro 08. Calendário de consultas do adolescente

CALENDÁRIO DE CONSULTAS DO ADOLESCENTE		
Fase de Crescimento	Consulta	
	Enfermagem/Médica*	Odontológica
No início da puberdade: meninas (entre 8 e 13 anos) e meninos (entre 9 e 14 anos)	De 3 em 3 meses	Anual
Aceleração	De 4 em 4 meses	
Desaceleração	Uma vez ao ano, próximo ao mês de aniversário	
Consulta de acompanhamento	Anual de 14 a 19 anos completos	

*Consultas intercaladas.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Cadernos de Atenção Básica, nº 33- Saúde da criança : Crescimento e Desenvolvimento. Secretaria de Atenção à Saúde.** Departamento de Atenção Básica. – Brasília : , 2012. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf. Acesso em 02/04/2025;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Linhas de Cuidado. **Puericultura e Hebicultura.** Brasília, 2021. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/puericultura/>. Acesso em 03/12/2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Método Canguru : manual da terceira etapa do Método Canguru na Atenção Básica** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018;

SANTA CATARINA. **Programa Bebê Precioso**, Joinville, 2009.